SDD 119 Sujet n°3

Spécialité : Gériatrie

Date : 30/10/2024
Auteur : Gaëlle Tisserand, DES MPR 2024
Relecteur(s) : Eloïse Francq, DES Gériatrie 2020, Lucie-Lou Vial (DES MAR, EN 2024)

Domaine d'apprentissage principal	Stratégie diagnostique
Domaine d'apprentissage secondaire	Communication interprofessionnelle
Item(s) en lien avec la station	108. Confusion, démences 132. Troubles cognitifs du sujet âgé 343. État confusionnel et trouble de conscience chez l'adulte et chez l'enfant
Situation(s) de départ en lien avec la station	119. Confusion mentale/désorientation 31. Perte d'autonomie progressive
Matériel nécessaire à la station	3 chaises - 1 table - papier de brouillon - stylos - iPad pour examinateurs
Contexte de la station	Explorer la confusion d'un patient âgé (causes)

ECOS TACFA
INSTRUCTIONS POUR LE/LA CANDIDAT.E

Contexte :
Vous êtes l'interne de garde aux urgences.
Vous recevez Mme Le Gall, 93 ans, amenée par le SAMU pour confusion.
Mme Le Gall est peu informative, vous décidez donc de discuter l'IDE des urgences qui a récupéré des informations en appelant l'EHPAD.

Consignes :
Vous avez 8 minutes pour :

- Chercher les causes possibles de confusion chez cette patiente
- Enoncer oralement vos prescriptions d'examens paracliniques et biologiques

Vous ne devez pas :

- Rédiger d'ordonnance

Attention : Vous avez 8 minutes. Au signal sonore, passez à la station suivante.

Il s'agit d'une station avec PSS

ECOS TACFA
GRILLE D'ÉVALUATION

Consigne(s) à l'évaluateur :

Aptitudes cliniques		
1.	Demande les dernières constantes : TA, FC, température, SpO2, FR *(point si toutes les constantes sont demandées)*	1 point
2.	Demande si une glycémie capillaire pour rechercher une hypoglycémie a été faite	1 point
3.	Demande si la patiente rapportait des douleurs récemment	1 point
4.	Demande s'il y a des troubles neurocognitifs sous-jacents et/ou cherche une rupture de l'état antérieur	1 point
5.	Demande à l'IDE les antécédents de la patiente (pathologies chroniques préexistantes et/ou pathologies psychiatriques chroniques)	1 point
6.	Demande l'ordonnance de la patiente	1 point
7.	Recherche l'introduction récente d'un médicament dans l'ordonnance	1 point
8.	Recherche le mode de vie : autonomie, aide pour les transferts, aide pour l'alimentation, immobilisation récente (1 point si au moins un item cherché)	1 point
9.	Demande s'il y a une consommation d'alcool et/ou de tabac	1 point
10.	Demande de quand datent les dernières urines ou recherche RAU via Bladder scan dans les examens complémentaires	1 point
11.	Demande de quand datent les dernières selles ou recherche fécalome via TR dans les examens complémentaires	1 point
12.	Demande s'il y a des troubles neuro-sensoriels (baisse de vision, baisse d'audition)	1 point
13.	Prescrit une bandelette urinaire pour rechercher une infection urinaire	1 point
14.	Prescrit un ECG pour rechercher une cause cardio-vasculaire (SCA, trouble du rythme, trouble de la conduction)	1 point

15.	Prescrit un bilan sanguin avec : NFS, ionogramme, urée, créatinine avec DFG, calcémie, CRP *(point si tous les éléments précédents sont cités)* +/- bilan hépatique et ECBU +/- TSH	1 point

Communications et attitudes

14.

6. COMMUNICATION AVEC LES PAIRS (clarté de communication)

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Est incapable de communiquer le message	Est capable de communiquer les principaux messages, n'arrive pas à les justifier	Est capable de communiquer les principaux messages et justifier son raisonnement	Communique les informations pertinentes et les justifie. Ne s'attarde pas à de l'information inutile	Relie les informations provenant des domaines différents faisant preuve d'une maîtrise du sujet

15.

7. APTITUDE À COOPÉRER avec les pairs

Performance Insuffisante 0 point	**Performance Limite** 0,25 point	**Performance Satisfaisante** 0,5 point	**Performance Très Satisfaisante** 0,75 point	**Performance Remarquable** 1 point
Autoritaire / Difficulté à coopérer	Communique. Transmet l'information	Communique. Adopte la technique de reformulation.	Communique les renseignements pertinents. Reconnaît les obstacles à la communication. Délègue les responsabilités en respectant les autres.	Reconnaît les problèmes de communication et sait les régler avec adresse.

16.

1. Échelle d'évaluation de performance globale: description générale

Performance Insuffisante *Clear fail*	**Performance Limite** *Borderline*	**Performance Satisfaisante** *Clear pass*	**Performance Très Satisfaisante** *Very good pass*	**Performance Remarquable** *Excellent pass*
Très au-dessous des attentes	Performance proche mais en dessous des attentes	**Conforme aux attentes**	**Au-delà des attentes**	**Très au-delà des attentes**
Les attentes sont non observables ou non respectées Présente un niveau inacceptable de connaissances ou de performance	Les omissions et les inexactitudes dans la réalisation des tâches Démontre du potentiel pour atteindre la compétence	Démontre les éléments essentiels de la performance Prêt pour avancer en toute sécurité	Quelques omissions/erreurs mineures et non essentielles Démontre la plupart des aspects de la compétence	Agit sans hésitation et sans erreur Démontre la maîtrise de tous les aspects de la compétence

TOTAL	**…/16 points**

<u>Éléments de rétroaction :</u>
La gériatrie est une matière difficile aux ECOS car les causes de confusion sont extrêmement nombreuses chez le sujet âgé.

Signes NEURO = DEXTRO !!

Extrait du Lisa :

Le syndrome confusionnel est déterminé par des facteurs de risque et par un facteur déclenchant (cause de la confusion), qui peut être neurologique ou non-neurologique. Le facteur déclenchant peut être minime (ex. infection urinaire) chez un sujet qui possède des facteurs de risque. Les facteurs de risque principaux sont :

- troubles neurosensoriels (anomalie de la vision ; baisse de l'audition/surdité)
- pathologies psychiatriques chroniques
- consommation d'alcool et de psychotropes
- immobilisation (hospitalisation, réanimation, phase de réveil post-opératoire)
- pathologie chronique préexistante
- trouble neurocognitif sous-jacent +++ : il est justifié de réévaluer l'état cognitif des patients à distance (à 6 mois) de l'épisode confusionnel

La confusion résulte d'une altération modérée de la vigilance. La démarche diagnostique se rapproche donc de celle du coma. Ses étapes sont les suivantes :

– Examen clinique général : constantes +++ incluant saturation O2, glycémie +++, morsure latérale de langue, recherche d'une cause de douleur aiguë (plaies, globe urinaire, fécalome), traces d'injections, globe urinaire, fécalome

– Examen neurologique : vigilance, pupilles, syndrome méningé, signe de focalisation, signes d'encéphalopathie (astérixis) ; clonies

– Reconstitution des antécédents (et notamment les traitements, la notion d'alcoolisme ou de prise de toxiques, de trouble neurocognitif) et de l'anamnèse +++ par l'interrogatoire des proches, des secouristes, du médecin traitant, l'obtention de documents médicaux etc.

– Examens paracliniques systématiques : hémogramme, ionogramme sanguin, urée, protides totaux, créatininémie avec calcul de la clairance de la créatinine, calcémie +++, CRP ; bandelette urinaire (leucocytes, nitrites) ; ECG ; auxquels on ajoute le plus souvent : ECBU, biologie hépatique

–Scanner cérébral sans injection : non systématique mais indiqué au moindre doute et formellement si :

- Signe de focalisation
- Traitement anticoagulant
- Traumatisme crânien récent
- Même en l'absence de signe de focalisation, le scanner cérébral sera le plus souvent nécessaire avant une ponction lombaire dans le cas d'un syndrome confusionnel important avec fluctuation de la vigilance (trouble de conscience = contre-indication à la PL sans imagerie)

– Ponction lombaire (analyse du liquide cérébro-spinal (LCS)) : non systématique mais indiquée formellement, en l'absence de contre-indication, si :

- Fièvre sans point d'appel
- Syndrome méningé
- Suspicion d'encéphalite (après TDM et/ou IRM)

– Autres examens de seconde intention (sur point d'appel et/ou en l'absence d'étiologie retrouvée au terme d'explorations)

- EEG (état de mal non convulsivant, encéphalopathie métabolique)
- échographie abdomino-pelvienne
- gaz du sang, enzymes cardiaques, ammoniémie, recherche de toxiques, dosages médicamenteux (prise volontaire ou involontaire d'un toxique ou d'un médicament potentiellement toxique)
- IRM encéphalique (si signe de focalisation et TDM normale, en urgence si début hyperaigu du syndrome confusionnel et suspicion de signe de focalisation pour écarter un AVC)

ECOS TACFA

SCÉNARIO PROFESSIONNEL DE SANTÉ SIMULÉ

Consignes génériques pour le patient :

- Ce que tu peux dire spontanément ou sous condition est clairement indiqué
- Si le candidat pose une question dont la réponse ne se trouve pas dans le scénario, n'improvise pas et réponds « je ne sais pas » ou « c'est normal ».

Rappel du scénario du candidat :

Contexte :
Vous êtes l'interne de garde aux urgences.
Vous recevez Mme Le Gall, 93 ans, amenée par le SAMU pour confusion.
Mme Le Gall est peu informative, vous décidez donc d'appeler l'IDE de son EHPAD.

Consignes :
Vous devez réaliser en 8 minutes :

- Chercher les causes possibles de confusion chez cette patiente
- Après avoir raccroché avec l'IDE, énoncer oralement vos prescriptions d'examens paracliniques et biologiques

Plan de la station ECOS :

Assis à une table face à l'étudiant

Phrase de démarrage du patient simulé (par <3) :

Bonjour Docteur, je viens de faire l'admission de Mme Le Gall. Le SAMU est reparti mais j'ai pu récupérer quelques éléments sur son dossier. Est-ce que vous avez des questions ?

Identité du professionnel de santé :

Vous êtes IDE aux urgences et l'IDE attitrée de Mme Le Gall, 93 ans, de corpulence normale (1m55, 50kg, IMC 20.8).

Mode de vie de la patiente :

Mme Le Gall vit en EHPAD mais semble relativement autonome.
Elle est en EHPAD, depuis le décès de son mari. Ses enfants vivant loin, ils ont préféré la mettre en EHPAD car elle avait du mal à gérer son domicile seule.

Elle marche avec une canne, elle est veuve, et elle a 2 enfants qui viennent la voir de temps en temps.
Pas de tabac pas d'alcool.
Pas d'allergie.

Comportement global :

Vous êtes soucieux d'aider l'étudiant dans la prise en charge.
Tenue d'IDE

Antécédents personnels de la patiente :

HTA
Coxarthrose
Ostéoporose

A dire seulement si l'étudiant le demande précisément :
Presbyacousie appareillée (a actuellement ses appareils sur elle si l'étudiant le demande)
Pas de trouble neuro-cognitif connu, pas de notion de chute ou de traumatisme crânien.
Pas d'immobilisation récente.

Antécédents familiaux de la patiente :

Inconnus

Médicaments :

ramipril 5mg 1cp matin
cholécalciférol tous les 3 mois + perfusion de biphosphonates une fois/an
paracétamol 500mg si besoin
Si l'étudiant le demande : pas d'introduction nouvelle de médicament d'après son dossier de l'EHPAD – pas de psychotrope – pas d'anticoagulant

Symptômes positifs :

La patiente ne se plaint de rien, mais elle raconte n'importe quoi, elle demande où est sa mère, elle se croit en 1960.

Constantes :

Si l'étudiant demande les constantes, lui faire préciser lesquelles, et ne donner que celles qu'il a demandé explicitement :
TA 140/90,
FC 85 bpm,
T° 37.2°C,
SaO2 96% en air ambiant
FR 14/min

Donnée complémentaire :

L'étudiant vous demandera plusieurs choses :
Glycémie capillaire « J'ai anticipé je l'ai fait à son arrivée aux urgences elle était à 1 g/L »

Questions de relance :

ECOS TACFA
FEUILLET ORGANISATEUR

Plan de la station ECOS :

Le patient est face à l'étudiant·e, un bureau séparant les deux personnes.

Matériel nécessaire à la station :

- *IPAD pour examinateur*
- *Feuille de brouillon pour candidat*
- *Stylo pour candidat*
- *Feuille de brouillon pour évaluateur*
- *Stylo pour évaluateur*

Documents présents dans la station :

- *Feuilles d'évaluation de papier de secours*